



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
НАКАЗ

від _____ 2025 року

Львів

№ _____

**Про Порядок організації
надання медичної допомоги
пацієнтам із гострим мозковим
інсультом у Львівській області**

Відповідно до наказів МОЗ України від 27.10.2021 № 2349 «Про затвердження Порядку міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги», від 15.06.2023 № 1091 «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом» та враховуючи лист МОЗ України від 17.04.2025 № 25/12639/2-25, -

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом (далі – ГМІ), що додається (далі - Порядок).

2. Визначити заклади охорони здоров'я (далі – ЗОЗ), які уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України за напрямом «**Медична допомога при гострому мозковому інсульті**» до яких транспортуватимуться пацієнти із ГМІ, і в яких наявне:

2.1. спеціалізоване інсультне відділення, в цілодобовому режимі здійснюється нейровізуалізація головного мозку, проводиться лабораторна діагностика, виконується моніторинг вітальних функцій, **реваскуляризаційні втручання шляхом внутрішньовенної тромболітичної терапії при ГМІ** (Додаток 1).

2.2. спеціалізоване інсультне відділення, в цілодобовому режимі здійснюється нейровізуалізація головного мозку, проводиться лабораторна діагностика, виконується моніторинг вітальних функцій, **реваскуляризаційні втручання шляхом внутрішньовенної тромболітичної терапії та ендovasкулярних нейроінтервенційних оперативних втручань при ГМІ** (Додаток 2).

2.3. спеціалізоване інсультне відділення, в цілодобовому режимі здійснюється нейровізуалізація головного мозку, проводиться лабораторна діагностика, виконується моніторинг вітальних функцій, **реваскуляризаційні втручання шляхом внутрішньовенної тромболітичної терапії та відкриті нейрохірургічні операції при ГМІ** (Додаток 3).

3. Керувати виконанням у пункті 2 цього наказу забезпечити:



Львівська ОДА
№22-205/04-14/25 від 24.04.2025
КЕП: ЛІТВІНСЬКА Н. С. 24.04.2025 14:18
5E984D526F82F38F0400000F0341F010A726C05

№22-205/04-14/25 від 24.04.2025

3.1. Навчання медичних працівників з ключових питань діагностики та лікування ГМІ.

3.2. Наявність в повному обсязі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги пацієнтам із ГМІ.

3.3. Надання медичної допомоги пацієнтам із підозрою на ГМІ у ЗОЗ відповідно до Порядку, клінічних маршрутів пацієнтів з ГМІ та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

3.4. Проведення моніторингу надання медичної допомоги пацієнтам з ГМІ в ЗОЗ відповідно до критеріїв, визначених у додатку 5 цього наказу, про що інформувати КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» до 5 числа наступного за звітним місяця на електронну адресу lvivphc.miac@gmail.com.

3.5. Наявність клінічних маршрутів пацієнтів з ГМІ на рівні ЗОЗ.

4. Керівнику КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» забезпечити:

4.1. Відповідно до Порядку госпіталізацію пацієнтів з ГМІ до ЗОЗ, визначених у пункті 2 цього наказу.

4.2. Навчання медичних працівників з ключових питань діагностики та лікування ГМІ.

4.3. Проведення моніторингу стану надання екстреної медичної допомоги пацієнтам із ГМІ відповідно до критеріїв, визначених у додатку 4 цього наказу, про що інформувати ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України» до 10 числа наступного за звітним місяця на електронну адресу disastermed2@ukr.net.

4.4. Цільовий час виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги з місця перебування, після отримання від диспетчера оперативно-диспетчерської служби звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги, що відноситься до категорії критичних та екстрених, не більше 2 хвилин.

4.5. Рекомендований час перебування бригади ЕМД на місці події при підозрі у пацієнта на ГМІ не більше 20 хвилин.

4.6. Рекомендований час перебування бригади у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги ЗОЗ при госпіталізації пацієнта з підозрою на ГМІ не більше 15 хв.

5. Керівнику КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» забезпечити узагальнення інформації, отриманої від закладів охорони здоров'я області, що здійснюють моніторинг за наданням медичної допомоги пацієнтам із ГМІ в закладі охорони здоров'я, який уклав договір з НСЗУ за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» та інформування департаменту охорони здоров'я до 10 числа наступного за звітним місяця на електронну адресу dephealth.lvivoda@gmail.com.

6. Керівникам ЗОЗ, які не уклали договір із Національною службою здоров'я України за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»:

6.1. **Заборонити** госпіталізацію пацієнтів з ГМІ.

6.2. У випадку звернення в заклад пацієнта з ГМІ або якщо у пацієнта, що перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі з'явилися симптоми ГМІ -

забезпечити **негайне** телефонне звернення чергового/ лікуючого лікаря ЗОЗ на лінію «103» з повідомленням про необхідність транспортування пацієнта з ГМІ до ЗОЗ визначених в пункті 2 наказу.

7. Керівникам закладів первинної медичної допомоги, у випадку звернення у заклад пацієнта з симптомами ГМІ, забезпечити **негайне** телефонне звернення на лінію «103» з повідомленням про необхідність транспортування такого пацієнта до ЗОЗ визначених в пункті 2 наказу.

8. Визнати таким, що втратив чинність наказ департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 09.10.2023 № 722 «Про Порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом (далі - ГМІ) у Львівській області».

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ЛІТВІНСЬКА

Марія Верес

ЗАТВЕРДЖУЮ

наказ департаменту охорони здоров'я

від _____ № _____

Порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом (ГМІ)

I. Загальні поняття

1. Цей Порядок визначає організацію надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом (далі - ГМІ) на догоспітальному та госпітальному етапах, а також порядок організації транспортування пацієнтів із ГМІ між закладами охорони здоров'я (далі - ЗОЗ).

2. Дія цього Порядку поширюється на ЗОЗ визначені пунктом 2 цього наказу, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відкриті нейрохірургічні операції при гострому мозковому інсульті - видалення внутрішньомозкового крововиливу, декомпресійна гемікраніектомія, закриття аномалій розвитку судин головного мозку, встановлення зовнішнього вентрикулярного дренажу;

визначений ЗОЗ - заклад охорони здоров'я, який визначений відповідно до пункту 2 цього Наказу, та який у режимі 24/7 (цілодобово 7 днів на тиждень) забезпечує здійснення нейровізуалізації головного мозку, проведення лабораторної діагностики, моніторинг вітальних функцій, реваскуляризаційних втручань та/або відкритих нейрохірургічних операцій при ГМІ, а також уклав договір із Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»;

найближчий ЗОЗ - визначений ЗОЗ який визначений відповідно до пункту 2 цього Наказу, що уклав договір з НСЗУ про медичне обслуговування населення за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» та час доїзду до цього ЗОЗ є найменшим, незалежно від місця його розташування;

нейровізуалізація - сканування головного мозку за допомогою комп'юторної або магнітно-резонансної томографії;

реваскуляризаційні втручання у пацієнтів із ГМІ - відновлення прохідності судин головного мозку шляхом проведення системної (внутрішньовенної) тромболітичної терапії або проведення ендоваскулярних нейроінтервенційних втручань (механічного видалення тромбу, що спричинив оклюзію великої церебральної судини та гостру ішемію ділянки мозку) при ГМІ, а також проведення ендоваскулярних нейроінтервенційних втручань при наявності аномалій розвитку судин головного мозку, що спричинили ГМІ;

транспортування пацієнтів із ГМІ між ЗОЗ - це перевезення пацієнтів, які знаходяться в ЗОЗ, в тому числі визначеному ЗОЗ, що не має необхідних матеріально-технічних та/або кадрових ресурсів для надання необхідного об'єму

медичної допомоги при ГМІ, до найближчого ЗОЗ, де така медична допомога може бути надана у повному обсязі.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Законі України «Про екстрену медичну допомогу» та інших нормативно-правових актах України.

4. Всі пацієнти з підозрою ГМІ підлягають екстреній госпіталізації бригадами екстреної медичної допомоги (далі - бригади ЕМД) у найближчий ЗОЗ.

Для проведення ендоваскулярних нейроінтервенційних втручань та/або відкритих нейрохірургічних операцій при ГМІ пацієнти транспортуються з визначеного ЗОЗ у найближчий ЗОЗ, в якому є можливість проведення таких втручань.

Пацієнти з підозрою на ГМІ мають бути госпіталізовані до найближчого ЗОЗ, що знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, якщо такий ЗОЗ є ближчим до місця перебування пацієнта.

5. «Стандартне вікно терапевтичних можливостей» у пацієнтів із ГМІ з моменту появи перших ознак захворювання складає для виконання внутрішньовенної тромболітичної терапії 4 години 30 хвилин, а для виконання механічної тромбектомії 6 годин.

«Розширене вікно терапевтичних можливостей» складає 24 години на підставі даних перфузійної нейровізуалізації головного мозку та/або даних магнітно-резонансної томографії головного мозку та відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

Якщо точний час початку захворювання (появи перших ознак ГМІ) невідомий, часом початку захворювання слід вважати момент, коли пацієнта востаннє хтось бачив або чув без ознак ГМІ.

II. Госпіталізації пацієнтів із підозрою на ГМІ бригадами ЕМД.

1. Керівник бригади ЕМД після проведення медичного огляду та встановлення попереднього діагнозу підозри на ГМІ приймає рішення про екстрену госпіталізацію. Рекомендований час перебування бригади ЕМД на місці події - не більше 20 хв.

2. Керівник бригади ЕМД повинен визначити, чи перебуває пацієнт у межах «вікна терапевтичних можливостей» для проведення реваскуляризаційних втручань у пацієнтів з ГМІ.

3. Пацієнт з підозрою на ГМІ повинен бути екстрено госпіталізований до найближчого ЗОЗ. Цільовий час транспортування - не більше 60 хв.

4. Госпіталізація пацієнтів із підозрою на ГМІ у межах «стандартного вікна терапевтичних можливостей» здійснюється до найближчого ЗОЗ.

5. Госпіталізація пацієнтів із підозрою на ГМІ внаслідок оклюзії великої церебральної судини здійснюється до найближчого ЗОЗ, в якому є можливість виконання ендоваскулярних нейроінтервенційних втручань. (Додаток 2)

6. Госпіталізація пацієнтів із підозрою на ГМІ у межах «розширеного вікна терапевтичних можливостей» здійснюється до найближчого ЗОЗ, в якому є можливість виконання перфузійної нейровізуалізації головного мозку та/або

магнітно-резонансної томографії головного мозку, а також виконання ендovasкулярних нейроінтервенційних втручань.(Додаток 2)

7. Госпіталізація пацієнтів із підозрою на ГМІ поза межами «стандартного та розширеного вікна терапевтичних можливостей» здійснюється до найближчого ЗОЗ.

8. Керівник бригади ЕМД невідкладно зв'язується доступними засобами зв'язку із старшим лікарем телеметричного координаційного сектору оперативно-диспетчерського відділу та повідомляє про екстрену госпіталізацію пацієнта із ГМІ, у тому числі зазначає необхідну інформацію стосовно пацієнта (вік, стать, час початку захворювання, рівень свідомості, ознаки вогнищового неврологічного дефіциту), та розрахунковий час прибуття до найближчого ЗОЗ.

9. Старший лікар телеметричного координаційного сектору оперативно-диспетчерського відділу:

9.1. повідомляє чергового лікаря найближчого ЗОЗ про екстрену госпіталізацію пацієнта із ГМІ, та передає отриману від керівника бригади ЕМД інформацію.

9.2. уточнює час прибуття пацієнта до лікарні і повідомляє його відповідальному або черговому лікарю ЗОЗ не пізніше, ніж за 10 хвилин до прибуття в ЗОЗ.

10. В разі виникнення додаткових запитань черговий лікар найближчого ЗОЗ контактує з старшим лікарем телеметричного координаційного сектору оперативно-диспетчерського відділу за номерами телефону (0679243983, 0638218309, 0679391234, 0638218240).

11. Якщо це можливо, протягом транспортування керівник бригади ЕМД підтримує зв'язок зі старшим лікарем телеметричного координаційного сектору оперативно-диспетчерського відділу/відповідальним або черговим лікарем найближчого ЗОЗ, куди прямує бригада ЕМД, та повідомляє про значні зміни у стані пацієнта.

12. Якщо приймальне відділення / відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги ЗОЗ та кабінет нейровізуалізації знаходяться у різних будівлях, після узгодження з відповідальним або черговим лікарем ЗОЗ, куди прямує бригада ЕМД, пацієнти із ГМІ доправляються бригадою ЕМД відразу до будівлі, де знаходиться кабінет нейровізуалізації.

13. Пацієнти із підозрою на ГМІ, які були доставлені до відповідного ЗОЗ бригадами ЕМД або звернулись самостійно, підлягають обов'язковому прийому черговими медичними працівниками приймального відділення/відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги незалежно від місця проживання, реєстрації, наявності чи відсутності документів, що посвідчують особу пацієнта, наявності декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

14. Прийом та подальше надання медичної допомоги пацієнтам із підозрою на ГМІ у ЗОЗ здійснюється відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

III. Організація транспортування пацієнтів із ГМІ між ЗОЗ

1. Транспортування пацієнтів із ГМІ між ЗОЗ здійснюється бригадами ЕМД.

2. Транспортування пацієнтів із ГМІ між ЗОЗ, виконується центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, як надання екстреної медичної допомоги.

3. У випадку наявності в ЗОЗ пацієнта з ГМІ, в якому не може бути надано повного об'єму медичної допомоги пацієнту з ГМІ, лікуючий/черговий лікар ЗОЗ **формує електронне скерування пацієнта та заявку на міжгоспітальне транспортування пацієнта** (додаток 6) і надсилає на електронну пошту КНП ЛОР ЛОЦЕМДМК: lvivemdmk103@gmail.com та телефонує за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги «103», повідомляє про необхідність транспортування пацієнта до найближчого ЗОЗ, у якому така допомога може бути надана в повному обсязі.
4. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає найближчий ЗОЗ відповідно до затвердженого маршруту пацієнтів з ГМІ до якого бригада ЕМД здійснюватиме транспортування пацієнта, передає цю інформацію бригаді ЕМД та найближчому ЗОЗ шляхом надсилання заявки на міжгоспітальне перевезення на електронну пошту інсультного відділення та інформування чергового лікаря ЗОЗ.
5. Бригада ЕМД під час транспортування пацієнта до найближчого ЗОЗ, заповнює «Супровідний листок. Талон до супровідного листка», затверджену наказом Міністерство охорони здоров'я України від 17 листопада 2010 року № 999, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 3 лютого 2011 року № 147/18885 (далі - форма № 114/о), за направленням на екстрену госпіталізацію (при відсутності такої можливості заповнюється паперова форма № 114/о).
6. Протягом усього часу транспортування медичні працівники бригади ЕМД повинні здійснювати медичний нагляд за пацієнтом.
7. Після того як пацієнта було госпіталізовано у найближчий ЗОЗ, керівник бригади ЕМД повинен повідомити в оперативно-диспетчерську службу час госпіталізації і зробити відповідний запис із номером реєстрації у формі первинної медичної облікової документації № 110/о «Карта виїзду швидкої медичної допомоги», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 листопада 2010 року № 999, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2011 року № 147/18885 (далі форма 110/о) та у формі 114/о.
8. Цей Порядок поширюється також на медичні бригади, які беруть участь в аеромедичній евакуації пацієнтів.